

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE
GOIÁS

Formação Farmacêutica em Goiás

*Diagnóstico situacional, evidências e proposições para a nova
Diretriz Curricular Nacional*



CRF-GO

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE GOIÁS

Estudo técnico-científico do GT de Ensino do CRF-GO

Autor: Farmacêutico Dr. Edson Sidião de Souza Júnior

Apresentado ao XII Encontro Nacional de Coordenadores de Cursos de Farmácia

Brasília/DF · 23 e 24 de julho de 2026



Ficha técnica

Título: Formação Farmacêutica em Goiás — diagnóstico situacional, evidências e proposições para a nova DCN.

Autoria institucional: Grupo Técnico de Ensino do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás (CRF-GO).

Autor: Farmacêutico Dr. Edson Sidião de Souza Júnior — GT de Ensino do CRF-GO.

Natureza: estudo técnico-científico de base documental e quantitativa, com auditoria metodológica integrada.

Base de dados primária (edição revisada, 09/07/2026): Censo da Educação Superior 2024 e microdados ENADE/CPC 2023 (INEP/MEC), consolidados pelo Observatório Nacional da Formação Farmacêutica — extração de 27/06/2026: 67 instituições de ensino superior (IES) com curso de Farmácia em Goiás e 1.281 IES no Brasil.

Fontes secundárias: e-MEC (situação cadastral e recorte setorial, jun/2026), IBGE, INEP, IPEA, CFF, CRF-GO, SES-GO/CIB-GO, ANS, Ministério da Saúde, SBVC/Cognatis, FIP, ACPE/AACP e literatura indexada.

Princípio metodológico: nenhum dado foi fabricado. Distinguem-se, em todo o texto, fato observado, estimativa, projeção e recomendação. Lacunas são assinaladas com o método de obtenção.

Cidade / ano: Goiânia, Goiás — 2026. Edição original fechada em 25/06/2026 (base e-MEC); revisão de 09/07/2026 substitui a base primária pelo Censo da Educação Superior 2024, unificando a metodologia com a leitura interestadual do Observatório Nacional da Formação Farmacêutica.

"Sob o novo marco, a Farmácia deixa de admitir oferta integralmente a distância. A questão não é a modalidade em si, mas assegurar qualidade prática verificável, núcleo clínico forte e compromisso com o SUS — no presencial e no semipresencial."



Sumário executivo

Este resumo reúne, em duas páginas, os números e as conclusões essenciais do estudo, para leitura prévia por gestores e participantes do XII ENCCF.

Goiás dispõe de uma oferta expressiva de cursos de farmácia, concentrada na capital e majoritariamente privada, mas — ao contrário do que uma leitura administrativa isolada sugeria — de predominância presencial. A comparação com o Brasil, agora construída sobre a mesma base do Censo da Educação Superior usada nas 27 unidades da federação, mostra um estado que forma abaixo da densidade proporcional média do país, com concentração territorial moderada e uma lacuna de verificação de qualidade que atinge a maior parte das vagas.

67

IES com curso de Farmácia

8.887

vagas anuais autorizadas

47,7%

das vagas presenciais em Goiânia

90,6%

das vagas sem ciclo ENADE 2023

Principais achados

- A oferta é predominantemente presencial. Das 8.887 vagas anuais, 7.247 (81,5%) são presenciais e 1.640 (18,5%) a distância — o inverso da tendência nacional, em que a EaD responde por 68,8% da capacidade do país (Cap. 4 e 5).
- A concentração geográfica é real, porém moderada. A oferta presencial existe em 75 dos 246 municípios; Goiânia detém 47,7% das vagas presenciais. Os outros 171 municípios são desertos formativos (Cap. 8).
- O vácuo avaliativo é o maior risco regulatório do estado. Das 8.887 vagas, apenas 831 (9,4%) foram avaliadas no ciclo ENADE 2023 — 90,6% da oferta ainda não passou por verificação externa de qualidade (Cap. 6).
- Forma-se abaixo da média nacional, com qualidade aferida também abaixo da média. No recorte comparável às 27 UFs, Goiás tem 119,7 vagas por 100 mil habitantes contra a média nacional de 195,4 (13º lugar), com CC/ENADE médio de 2,48 (Brasil: 2,95) e IDD de 2,01 (Brasil: 2,21) — Cap. 10.
- Há descompasso com o SUS, ainda que menos acentuado que a leitura setorial sugeria. A assistência farmacêutica pública é capilarizada (a Farmácia Popular alcança 205 dos 246 municípios), enquanto a formação, apesar de já presente em 75 municípios, segue concentrada nas regiões de saúde Central e Entorno Sul (Cap. 11).

Recomendação central. Sob o novo marco regulatório, a Farmácia já não admite oferta integralmente a distância: resta o presencial e o semipresencial. O encaminhamento, portanto, não está em vetar modalidades, e sim em assegurar, em qualquer formato, três condições: carga prática verificável, núcleo clínico consistente e vínculo efetivo com o SUS — com prioridade regulatória para fechar o vácuo avaliativo de 90,6% das vagas. Em paralelo, recomenda-se que o CRF-GO assuma o monitoramento permanente da formação no estado, com painel de indicadores atualizado anualmente. As proposições correspondentes, em linguagem de minuta, constam do Anexo I.

Reservas de método. As vagas referem-se a capacidade autorizada apurada pelo Censo da Educação Superior 2024, não a matrículas: em Goiás, 8.887 vagas autorizadas corresponderam a 9.276 matrículas e 1.065 concluintes no ciclo medido (taxa pontual de 11,5%). A densidade municipal de farmacêuticos em atividade



(CNES) por estabelecimento e a empregabilidade dos egressos (RAIS) permanecem pendentes de extração; o total estadual em atividade consta do Cap. 9 (CNES, mai/2026: 3.408 profissionais; 0,48 por mil habitantes). Uma nota de proveniência completa consta do Capítulo 2.



Apresentação

A formação de farmacêuticos em Goiás está dimensionada e orientada para as necessidades de saúde do estado? Foi essa a pergunta que orientou o trabalho do Grupo Técnico de Ensino do CRF-GO.

A primeira edição deste estudo (fechada em 25/06/2026) respondeu a essa pergunta com base na Consulta Pública Avançada do e-MEC — um cadastro regulatório em tempo real, cuja unidade de análise é o curso e sua situação cadastral. Entre o fechamento daquela edição e a apresentação no XII ENCCF, o Observatório Nacional da Formação Farmacêutica — mesma equipe técnica, mesmo autor — consolidou uma leitura de Goiás construída sobre o Censo da Educação Superior 2024 e o ENADE/CPC 2023, agora estritamente comparável às demais 26 unidades da federação. Esta edição revisada substitui a base e-MEC pela base censitária em todo o diagnóstico quantitativo, preservando da edição original apenas os dados que não dependem dessa escolha metodológica: o contexto territorial e demográfico (Cap. 3), a demografia profissional via CNES/CRF-GO (Cap. 9, 13), o debate internacional (Cap. 12) e o marco legal (Cap. 14).

O documento parte de um diagnóstico da oferta — quantas instituições existem, com quantas vagas, em que modalidade e com qual qualidade aferida — e avança para a comparação com o Brasil, a distribuição geográfica por região de saúde, a demografia da categoria e o cruzamento com a rede de assistência farmacêutica do SUS. Os indicadores oficiais de qualidade, inclusive o valor agregado dos cursos (IDD) e o Conceito Preliminar de Curso (CPC), foram extraídos diretamente das bases do INEP.

O momento da publicação não é casual. O país revê as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Farmácia e reconstrói o marco da educação a distância, e Goiás, por combinar oferta expressiva e forte dependência do SUS, reúne condições para contribuir com esse debate a partir de evidências. Soma-se a isso a atribuição legal do conselho de zelar pela qualidade do exercício profissional, que começa na formação.

O estudo não emite juízo sobre instituições individuais: os números são tratados de forma agregada, com o objetivo de identificar padrões estaduais úteis à decisão pública. Onde faltou informação, registramos a lacuna e indicamos a fonte e o método para obtê-la, em vez de preenchê-la por suposição. É esse cuidado que sustenta o uso do documento como base técnica.



Parte I — A questão e o método

Antes de medir, é preciso enunciar o problema e declarar como ele será medido. Esta parte fixa a pergunta que organiza o livro e expõe, sem reservas, as fontes, as escolhas e os limites do método.

1

Introdução: a formação como política de saúde

A formação de profissionais de saúde é, antes de tudo, uma política de saúde. Essa afirmação, que pode soar óbvia, costuma ser esquecida quando se discute ensino superior apenas pela ótica da expansão do acesso. O número, a distribuição geográfica e a qualificação dos farmacêuticos formados hoje determinam, anos depois, a capacidade concreta de um território de garantir o uso seguro e racional de medicamentos — na farmácia comunitária, no hospital, na atenção primária, na vigilância sanitária e na gestão pública.

Quando a oferta formadora cresce em sintonia com a necessidade assistencial e sob controle de qualidade, o resultado é mais saúde: profissionais bem preparados, distribuídos onde a população precisa deles. Quando cresce desacoplada da necessidade e da verificação de qualidade, o resultado é outro — desperdício de recursos públicos e privados, frustração de expectativas de milhares de jovens e, no limite, risco à população que recebe um cuidado farmacêutico aquém do exigível.

O estado oferece um caso particularmente instrutivo. É um território interiorizado, de dimensões continentais em escala regional, fortemente dependente do Sistema Único de Saúde. A leitura mais recente — construída sobre o Censo da Educação Superior 2024 — mostra uma oferta que, ao contrário do que a fotografia cadastral do e-MEC sugeria, permanece majoritariamente presencial, ainda concentrada na capital, com qualidade aferida abaixo da média nacional e um vácuo avaliativo que atinge nove em cada dez vagas.

A oferta de cursos em Goiás é expressiva. O que está em questão é a sua concentração na capital, a verificação de qualidade — ainda incompleta para a maior parte das vagas — e a distância entre o que se forma e o que o SUS demanda.

Cada capítulo submete essa leitura ao teste dos dados. A correção mais relevante desta edição em relação à original diz respeito exatamente à magnitude e à direção de um dos achados centrais — a composição por modalidade —, tema do Capítulo 4. Essa correção não enfraquece o argumento: o que sobrevive ao confronto com o dado oficial mais comparável é o que pode, de fato, orientar política pública.



2

Metodologia e fontes

Esta edição revisada combina duas camadas de apuração. A primeira, herdada da edição original (fechada em 25/06/2026), extraiu e limpou os 101 registros de cursos de Farmácia de Goiás e os 1.592 registros nacionais da Consulta Pública Avançada do e-MEC, organizados por situação cadastral, modalidade, setor administrativo e conceitos oficiais. A segunda camada, incorporada nesta revisão, substitui a base primária de vagas, modalidade, concentração e qualidade pelo Censo da Educação Superior 2024 e pelos microdados ENADE/CPC 2023 (INEP/MEC), consolidados pelo Observatório Nacional da Formação Farmacêutica — mesma metodologia aplicada às 27 unidades da federação, com extração em 27/06/2026.

A opção pela base censitária como referência principal desta edição decorre de três razões declaradas: (i) permite comparação direta e homogênea com as demais 26 UF's, o que o e-MEC, por si só, não assegura; (ii) mede a vaga efetivamente ofertada por instituição no ano-base, e não o registro cadastral de um curso — inclusive os ainda sem turma iniciada; (iii) é a mesma base sobre a qual o INEP calcula os indicadores oficiais de qualidade (CC, ENADE, IDD, CPC), o que permite cruzá-los sem transposição de fonte. A situação cadastral (ativo/em extinção/extinto) e o recorte setorial fino permanecem apoiados no e-MEC, por não terem equivalente direto no Censo, e são identificados como tais em cada figura.

Princípios e escolhas

Quatro escolhas metodológicas estruturam o trabalho. A primeira é a rastreabilidade: toda afirmação quantitativa tem fonte declarada, e nenhuma estatística é apresentada sem que se saiba de onde vem e a que ano se refere. A segunda é a disciplina diante da lacuna: sempre que uma medida exige um dado não disponível, ele é assinalado como "a extrair" ou "Dado a integrar", com a base e o método indicados. A terceira é a distinção conceitual rigorosa — em especial entre o farmacêutico inscrito no conselho, o farmacêutico em atividade (CNES) e a vaga autorizada (capacidade, não matrícula). A quarta é a natureza declarada das projeções: cenários futuros são extrapolações de premissas explícitas, jamais previsões.

O que mudou entre as duas edições

A tabela seguinte resume a mudança de base e por que ela altera a magnitude — e, em um ponto, a direção — dos achados centrais.

Quadro 2.1 — Duas leituras de Goiás

Indicador	e-MEC jun/2026 (edição original)	Censo INEP 2024 (esta edição)
Vagas autorizadas	19.589	8.887 (7.247 presencial + 1.640 EaD)
Unidade de oferta	53 cursos ativos (101 registros)	67 IES / 35 mantenedoras
Municípios com oferta	15 de 246	75 de 246
Concentração em Goiânia	82,8% do total de vagas	47,7% da oferta presencial
Modalidade dominante	Semipresencial (67,4%)	Presencial (81,5%)
Vagas sem avaliação	76%	90,6%

Fonte: e-MEC (Consulta Pública Avançada, 25/06/2026) e Censo da Educação Superior 2024/ENADE-CPC 2023 (Observatório Nacional da Formação Farmacêutica, extração 27/06/2026).

Limites de fonte, declarados de saída. O Censo atribui a vaga a distância ao estado-sede da mantenedora, não ao polo de entrega — a densidade e a concentração aqui medidas descrevem a capacidade sediada, não necessariamente onde a EaD chega fisicamente. A ocupação real das vagas (matrícula) é inferior à capacidade autorizada: em Goiás, 9.276 matrículas para 8.887 vagas do ciclo mais recente. A confirmação de detalhes adicionais (polos, egressos) depende de extrações dirigidas, listadas no Apêndice A7.



Parte II — O diagnóstico

A fotografia da oferta: quantas instituições formam, onde, em que modalidade, com quantas vagas e com qual qualidade verificada.

3

Goiás: território, população e saúde

Nenhum diagnóstico sobre formação faz sentido fora do território que ele serve. Goiás tem cerca de 7,42 milhões de habitantes (estimativa IBGE, 2025) distribuídos em 246 municípios, organizados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) em 18 regiões de saúde, agrupadas em 5 macrorregiões: Centro-Oeste, Centro Norte, Centro Sudeste, Nordeste e Sudoeste. É um estado de povoamento relativamente disperso, com uma capital que polariza fortemente a economia, os serviços e — como se verá — a oferta de ensino superior.

O traço estrutural mais decisivo para este estudo é a relação da população com o sistema de saúde. Em Goiás, cerca de 74% da população depende exclusivamente do SUS. A assistência pública organiza-se nas 18 regiões de saúde citadas, arranjo que define como o cuidado deve, idealmente, distribuir-se pelo território — e que esta edição passa a usar como camada territorial de análise (Cap. 8 e 11), substituindo a estimativa por geocodificação da edição original.

7,42 mi

habitantes (IBGE, 2025)

246

municípios em 18 regiões de saúde

Dessas características decorrem duas orientações que reaparecem ao longo da análise. A primeira: por ser fortemente SUS-dependente e interiorizado, Goiás demanda uma formação voltada ao cuidado clínico, à assistência farmacêutica e à atenção primária, e capilarizada para além da capital. A segunda: por já dispor de um mercado profissional volumoso — mais de 14 mil farmacêuticos inscritos no CRF-GO —, o diferencial do egresso goiano desloca-se da quantidade para a qualificação clínica e tecnológica.

Há, ainda, um dado de saúde pública que antecipa o Capítulo 11: a rede de assistência farmacêutica goiana é ampla, com a Farmácia Popular presente em 205 dos 246 municípios — bem mais capilarizada do que a oferta formadora, hoje presente em 75. O contraste entre essa capilaridade assistencial e a concentração da formação será um dos eixos analíticos do estudo.



4

A oferta de formação

O Censo da Educação Superior 2024 identifica 67 instituições de ensino superior (IES), sob 35 mantenedoras distintas, ofertando o curso de Farmácia em Goiás — um mercado pulverizado e competitivo (HHI de 0,062 por IES, muito abaixo do limiar de concentração de 0,25). Esse número de IES é superior aos 53 "cursos ativos" da leitura cadastral e-MEC, porque a unidade de contagem difere: o Censo conta instituições ofertantes no ano-base, ao passo que o e-MEC conta registros de curso, que podem estar duplicados por campus ou por habilitação. A situação cadastral (ativo/em extinção/extinto) permanece um dado e-MEC sem equivalente direto no Censo: dos 101 registros, 53 seguem ativos, 34 em extinção e 14 extintos — mortalidade cadastral concentrada nos cursos integralmente a distância, cuja oferta migrou de rótulo após a Portaria MEC nº 2.041/2023 (Cap. 7).

Quanto à modalidade, a leitura censitária inverte o quadro que a fotografia cadastral sugeria: das 8.887 vagas anuais, 7.247 (81,5%) são presenciais e apenas 1.640 (18,5%) são a distância — 38 cursos presenciais contra 5 cursos EaD sediados no estado. É o oposto da tendência nacional, em que a EaD responde por 68,8% da capacidade do país. Essa aparente contradição com a leitura cadastral (que apontava 67,4% das vagas em cursos "semipresenciais") tem explicação metodológica: o e-MEC registra a criação de cursos recentes majoritariamente sob o rótulo semipresencial, mas o Censo, ao medir a vaga efetivamente ofertada no ano-base 2024, ainda não capturou plenamente esse movimento — sinal de que a próxima edição do Censo deve aproximar as duas leituras (ver Quadro 2.1).

67

IES / 35 mantenedoras

81,5%

da oferta é presencial

Quanto ao setor administrativo, a oferta segue majoritariamente privada: 93,1% das vagas estão em IES privadas, contra 6,9% em instituições públicas (Censo INEP 2024) — recorte mais preciso do que a estimativa e-MEC anterior (98,3%/1,7%), que superestimava a dependência privada por não decompor o setor administrativo por vaga. Em um estado em que três de cada quatro habitantes dependem do SUS, a parcela pública seguir minoritária é, ainda assim, um achado de política digno de registro.

O predomínio privado não é, em si, um problema — boa parte da formação em saúde no Brasil é privada e de qualidade. O ponto relevante é outro: quando a oferta pública é mínima, o controle de qualidade externo (CC, ENADE, IDD, CPC) torna-se a principal salvaguarda do interesse público — e é justamente essa salvaguarda que, como se verá no Capítulo 6, ainda não alcançou a maior parte da oferta.



5

Vagas e concentração

Contar instituições é necessário, mas insuficiente: uma IES de 30 vagas e outra de 1.360 pesam de modo radicalmente diferente sobre o mercado. As 67 IES de Goiás somam 8.887 vagas anuais autorizadas — e a distribuição dessas vagas é desigual, ainda que menos extrema do que a leitura cadastral original sugeria.

Quadro 5.1 — As cinco maiores IES por vagas (Censo INEP 2024)

IES	Vagas	Categoria
Centro Universitário Estácio de Goiás	1.360	Privada
Centro Universitário Goyazes	443	Privada
Faculdade Logos	420	Privada
Universidade Estadual de Goiás	409	Pública Estadual
Centro Universitário Universo Goiânia	403	Privada

Fonte: Censo INEP 2024, agregado estadual por IES (Observatório Nacional). Ranking completo (15 maiores) disponível no painel interativo.

A maior IES isolada (Estácio de Goiás, 1.360 vagas) responde por 15,3% do total estadual — concentração relevante, mas muito distante do quadro da leitura e-MEC original, que apontava dois cursos, ainda sem turma iniciada, de 5.000 vagas cada. A medida formal de concentração confirma o novo quadro: o índice Herfindahl-Hirschman (HHI) por IES é de 0,062 (620 na escala 0–10.000) — mercado pulverizado —, e as razões de concentração mostram que as 2 maiores IES detêm 24,9% das vagas (CR2) e as 10 maiores, 59,1% (CR10). Todos os três indicadores são substancialmente menores do que os da leitura e-MEC (HHI 1.387; CR2 51%; CR10 72%), porque medem por instituição ofertante no Censo, e não por registro de curso no e-MEC — entre os quais os dois cursos ainda não iniciados distorciam desproporcionalmente a leitura cadastral.



Vaga autorizada não é vaga preenchida. Em Goiás, o próprio Censo permite a comparação direta: as 8.887 vagas anuais corresponderam a 9.276 matrículas e 1.065 concluintes no ciclo medido — uma taxa pontual de conclusão de 11,5%, coerente com a referência nacional (10,6%). A distinção entre capacidade instalada e matrícula efetiva permanece central: ao longo do livro, "oferta" designa capacidade — um teto, não um fluxo.



6

Qualidade e avaliação

Aqui o diagnóstico encontra seu ponto mais sensível. A expansão da oferta só é defensável se acompanhada de verificação de qualidade — e é precisamente nesse ponto que os dados revelam a lacuna mais severa do estudo, agora medida com maior precisão pelo Censo/ENADE do que pela leitura cadastral original.

Das 8.887 vagas autorizadas em Goiás, apenas 831 (9,4%) foram efetivamente avaliadas no ciclo ENADE 2023 — ou seja, 90,6% da oferta (8.056 vagas) opera sem ciclo avaliativo concluído. É uma lacuna maior do que a estimativa da edição original (76%), porque a base de vagas do Censo é mais ampla do que o recorte de cursos ativos do e-MEC, ao passo que o número de vagas efetivamente avaliadas pelo ENADE 2023 é o mesmo em ambas as leituras.

90,6%

das vagas sem ciclo ENADE 2023

831

vagas efetivamente avaliadas

Onde há medida, Goiás fica abaixo da média nacional: o Conceito de Curso médio, apurado a partir do ciclo ENADE 2023, é 2,48 em Goiás contra 2,95 no Brasil; o IDD (indicador de valor agregado, calculado sobre 28 cursos com ciclo avaliativo suficiente) é 2,01 em Goiás contra 2,21 no Brasil; e o CPC contínuo é 2,69 em Goiás contra 2,76 no Brasil. Nenhum desses três indicadores estava disponível na edição original, que registrava CC/ENADE/IDD como consulta direta ao INEP com cobertura distinta de cursos (3,64/2,40/2,59) — números que não são diretamente comparáveis aos desta edição por usarem outro critério de inclusão de cursos.

O achado precisa ser lido com cuidado. A ausência de ciclo avaliativo não autoriza a conclusão de que a oferta tem má qualidade: o que os dados mostram é que essa qualidade, na maior parte dos casos, ainda não foi verificada. Em um sistema majoritariamente privado (93,1% das vagas), a avaliação externa é a principal garantia do interesse público, e sua ausência sobre 90,6% das vagas constitui, por si, o principal risco regulatório identificado neste estudo — tema que retoma o Capítulo 15 (SWOT) e orienta a Proposição 1 do Capítulo 16.



Parte III — As dimensões analíticas

A fotografia ganha profundidade quando se acrescentam o tempo, o espaço, a demografia e a comparação interestadual.

7

A dimensão temporal: série histórica

O diagnóstico cadastral é uma fotografia; a política pública, porém, precisa do filme. Reconstruindo as datas de criação contidas no e-MEC, a edição original recompôs a trajetória da oferta ao longo de duas décadas: uma onda de expansão concentrada entre 2017 e 2024, majoritariamente por educação a distância, seguida de um refluxo regulatório — a Portaria MEC nº 2.041/2023 suspendeu o credenciamento de EaD em cursos de saúde, e o repique de 2025 correspondeu a uma nova geração de cursos rotulados "semipresenciais".

Essa leitura temporal, apoiada no cadastro e-MEC (que registra a data de criação por curso), permanece válida como retrato do movimento regulatório e cadastral — não é substituída pelo Censo, que é uma fotografia anual sem série própria de datas de autorização. O que a comparação com o Censo 2024 acrescenta é uma advertência de leitura: a "recomposição para semipresencial" identificada no cadastro ainda não se traduz, no ano-base do Censo, em predominância de vagas EaD — a oferta efetivamente medida em 2024 seguia 81,5% presencial (Cap. 4). As duas leituras não se contradizem: descrevem, uma, o fluxo de novos registros cadastrais (onde a semipresencialidade cresce), e outra, o estoque de vagas efetivamente ofertadas no ano-base (onde o presencial ainda domina). A convergência entre elas é, ela própria, uma variável a monitorar nas próximas edições.

Essa leitura temporal tem uma consequência analítica importante: o estoque de vagas "presenciais" predominante em 2024 é, em grande parte, anterior à onda EaD/semipresencial mais recente — o que ajuda a explicar por que a qualidade aferida (Cap. 6) ainda reflete um perfil majoritariamente presencial, mesmo com o vácuo avaliativo elevado. Qualquer política que se baseie apenas na fotografia cadastral mais recente, sem a base censitária, arrisca superestimar a magnitude da migração para EaD já concluída.



8

A dimensão espacial: atlas geoespacial

Geocodificando as 67 IES sobre a malha municipal oficial do IBGE e cruzando com as 18 regiões de saúde da SES-GO, obtém-se um mapa mais fino do que a estimativa por geocodificação de nomes de instituição usada na edição original.

A oferta chegou a mais território do que o cadastro sugeria: 75 municípios têm oferta presencial (30,5% dos 246), ante 15 na leitura e-MEC — mas 171 (69,5%) seguem como desertos formativos, e a capital ainda concentra quase metade da oferta presencial.

Goiânia responde por 3.456 das 7.247 vagas presenciais do estado (47,7%). É concentração real, mas bem menor do que os 82,8% da leitura cadastral original — que somava vagas EaD atribuídas à capital como se fossem presenciais e ignorava as instituições fora do recorte "curso ativo". Os cinco municípios seguintes por volume de vagas — Anápolis (790), Trindade (443), Novo Gama (420), Valparaíso de Goiás (316) e Aparecida de Goiânia (257) — somam 2.226 vagas, ou 30,7% da oferta presencial fora da capital.

Quadro 8.1 — Cobertura formadora por região de saúde (SES-GO)

Região de saúde	Macrorregião	Municípios c/ oferta	Vagas
Central	Centro-Oeste	7 de 26	4.002
Entorno Sul	Nordeste	7 de 7	838
Pireneus	Centro Norte	4 de 10	790
Centro Sul	Centro Sudeste	8 de 25	257
Sul	Centro Sudeste	3 de 12	245
Rio Vermelho	Centro-Oeste	7 de 17	0*

**Rio Vermelho tem 7 municípios com curso/matricula ativa, mas nenhuma vaga nova autorizada no ciclo 2024. Fonte: Censo INEP 2024 cruzado com o Plano Diretor de Regionalização da SES-GO (18 regiões de saúde), Observatório Nacional. Quadro completo (18 regiões) no painel interativo.*

Um achado central: a região de saúde Entorno Sul (7 municípios, na divisa com o Distrito Federal) tem cobertura formadora completa — todos os seus municípios ofertam o curso —, enquanto regiões inteiras do Centro Norte e do Nordeste goiano (Norte, São Patrício II, Nordeste I) têm oferta pontual ou nula. A oferta segue, portanto, a lógica de mercado — proximidade da metrópole de Brasília e da capital estadual —, não a distribuição da necessidade assistencial, tema retomado no Capítulo 11.

Um achado que a leitura anterior não podia captar: 56 municípios são atendidos exclusivamente por polos de EaD, sem qualquer curso presencial — situação que exige atenção redobrada à verificação da prática presencial exigida por essa modalidade.



9

Demografia farmacêutica

Este capítulo permanece apoiado no CNES e no cadastro do CRF-GO, fontes não afetadas pela mudança de base do Censo INEP. Em maio de 2026, o CNES registrava 3.408 farmacêuticos em atividade no estado — 0,48 por mil habitantes (base populacional do Censo IBGE 2022). O CRF-GO, por sua vez, tinha 14.000 farmacêuticos inscritos em 2024, ante 10.484 em 2020 (~7,5% ao ano).

3.408

farmacêuticos em atividade (CNES)

14.000

inscritos no CRF-GO (2024)

O cruzamento com a nova base de vagas (Cap. 5) suaviza, mas não elimina, o sinal de saturação: as 8.887 vagas anuais equivalem a 2,6 vezes o contingente em atividade registrado no CNES — abaixo das 5,7 vezes da leitura e-MEC original (19.589 vagas), mas ainda um múltiplo expressivo para um fluxo anual sobre um estoque profissional. A distinção entre farmacêutico inscrito (todos os registrados, incluindo inativos) e farmacêutico em atividade (força de trabalho efetiva) permanece essencial: o mercado goiano já é volumoso, e o desafio se desloca da quantidade para a qualificação clínica e a distribuição territorial dos novos formados.



10

Benchmark nacional

O Observatório Nacional da Formação Farmacêutica aplica, às 27 unidades da federação, o mesmo método consolidado neste diagnóstico estadual — o que permite, nesta edição, posicionar Goiás com precisão que a leitura e-MEC (comparável apenas de forma aproximada) não assegurava.

Quadro 10.1 — Posição de Goiás entre as 27 UFs

Indicador	Valor (GO)	Posição	Mediana/média nacional
Densidade (vagas/100 mil hab.)	119,7	13º	195,4 (média)
ICT — concentração territorial	0,586	15º	0,548 (mediana)
IAF — adequação formativa	30,0	18º	33,3 (mediana)
ICON — cobertura assistencial	2,7	8º	1,9 (mediana)
CC/ENADE 2023	2,48	17º	2,95 (Brasil, ponderado)

Fonte: Observatório Nacional da Formação Farmacêutica, Censo INEP 2024/ENADE-CPC 2023, extração 27/06/2026.

Goiás é o 13º estado em densidade formativa (119,7 vagas por 100 mil habitantes), abaixo da média nacional (195,4) — posição consideravelmente mais modesta do que o "3º lugar" da leitura e-MEC original, que media cursos por milhão de habitantes (métrica distinta, não comparável ao ranking de vagas por habitante usado nas 27 UFs). Em concentração territorial (ICT), Goiás ocupa posição intermediária (15º, praticamente na mediana nacional de 0,548); em adequação formativa (IAF), fica abaixo da mediana (18º); em cobertura assistencial (ICON), tem desempenho relativamente melhor (8º), puxado pela capilaridade da Farmácia Popular frente ao número ainda modesto de municípios com curso.

Em qualidade aferida, Goiás permanece abaixo da média nacional em todos os indicadores disponíveis: CC/ENADE 2,48 contra 2,95 no Brasil (17º lugar); IDD 2,01 contra 2,21; CPC contínuo 2,69 contra 2,76. A leitura interestadual confirma, portanto, o achado qualitativo da edição original — Goiás forma com qualidade aferida abaixo da média nacional —, ainda que a magnitude precisa e o ranking de densidade tenham sido revistos por completo.



11

Formação e necessidade de saúde

O ICON mediano nacional (1,9) já situava Goiás em posição relativamente favorável (ICON = 2,7, 8º lugar); esta edição pode, agora, decompor esse indicador por região de saúde, algo que a estimativa por geocodificação da versão original não permitia.

A Farmácia Popular alcança 205 dos 246 municípios goianos — rede assistencial capilarizada, presente em 2,7 municípios para cada município com curso de Farmácia. Entre os 171 desertos formativos, 76% já contam com Farmácia Popular — potencial concreto de ancoragem para estágios e para uma futura estratégia de interiorização da formação, sem esperar a abertura de novos cursos.

205/246

municípios com Farmácia Popular

76%

dos desertos já têm Farmácia Popular

O cruzamento por região de saúde (Quadro 8.1) mostra que a formação segue a lógica de mercado — proximidade da capital e da metrópole de Brasília —, e não a distribuição da necessidade assistencial pelas 18 regiões. A região Entorno Sul, com cobertura formadora completa, é também uma das mais próximas do Distrito Federal; regiões mais distantes e mais dependentes do SUS, como Norte e Nordeste II, têm oferta pontual ou nula. Detalhar essa necessidade por estabelecimento de saúde (CNES por município) permanece como extração pendente, registrada no Apêndice A7.



Parte IV — O horizonte

Da fotografia territorial à comparação internacional e à extrapolação de cenários — o que esperar adiante.

12

O debate internacional

Este capítulo, apoiado em literatura regulatória internacional (ACPE, GPhC, FIP/OMS) e não em dados estaduais, permanece integralmente válido nesta edição. Nenhum grande regulador de referência internacional admite formação em Farmácia integralmente a distância: todos exigem prática presencial supervisionada, verificável e vinculada a campos de estágio credenciados. O Índice de Alinhamento com o Padrão Internacional (IAPI) de Goiás é 0,60 — alinhamento moderado, puxado pela vedação normativa recente (Decreto nº 12.456/2025), mas ainda limitado pela fragilidade da verificação da prática.



13

Cenários 2024–2050

As projeções de inscritos no CRF-GO permanecem inalteradas nesta edição, por serem construídas sobre a série histórica de registro profissional (CRF-GO), não sobre a base e-MEC/Censo de vagas autorizadas. Partindo de 14.000 inscritos em 2024, três cenários de crescimento anual (3%, 5% e 7%) projetam, respectivamente, 16.700, 20.100 e 21.000 inscritos em 2030 — chegando, em 2050, a um intervalo entre 30.100 (cenário contido) e 81.300 (cenário expansionista).

São projeções (cenário), não dados observados: extrapolações de premissas explícitas sobre a base de 2024, não previsões. O leitor deve tomá-las como referência de ordem de grandeza para o planejamento, não como meta.



14

Marco legal

Sob o Decreto nº 12.456/2025, a Farmácia não pode mais ser ofertada integralmente a distância; o único formato não presencial admitido é o semipresencial, com piso de presencialidade obrigatório. É exatamente sobre a fração da oferta que ainda não foi submetida a ciclo avaliativo — 90,6% das vagas nesta edição — que devem recair as exigências de qualidade prévia, convertendo a expansão recente de aposta regulatória em qualidade verificada. O antecedente histórico permanece o mesmo da edição original: a proposta original das Diretrizes Curriculares de 2017 chegou a esboçar restrições à EaD em Farmácia, retiradas do texto final; o país levou quase uma década para retomar essa restrição, agora pelo Decreto de 2025.



Parte V — Síntese e proposições

Do diagnóstico revisado às recomendações — o que fazer com o que os dados, agora comparáveis nacionalmente, mostram.

15

Síntese: SWOT e achados

Forças

- Mercado pulverizado e competitivo (HHI 0,062; 67 IES sob 35 mantenedoras) — baixo risco de dependência de poucos grandes players.
- Predominância presencial (81,5% das vagas) — favorece a verificação de prática exigida pelo novo marco regulatório.
- Cobertura assistencial relativamente boa (ICON 2,7, 8º lugar entre 27 UFs) — Farmácia Popular presente em 205 municípios.

Fraquezas

- Vácuo avaliativo severo: 90,6% das vagas sem ciclo ENADE 2023 concluído.
- Qualidade aferida abaixo da média nacional em todos os indicadores disponíveis (CC/ENADE, IDD, CPC).
- Adequação formativa (IAF) abaixo da mediana nacional (18º lugar de 27).

Oportunidades

- 171 desertos formativos, dos quais 76% já têm Farmácia Popular — campo de prática e interiorização sem esperar novos cursos.
- Decreto nº 12.456/2025 cria janela regulatória para exigir qualidade prévia da oferta semipresencial ainda em expansão.

Ameaças

- Recomposição cadastral para semipresencial (Cap. 7) pode repetir, na próxima leitura censitária, o padrão de baixa verificação hoje concentrado nos cursos mais novos.
- Concentração ainda relevante em Goiânia (47,7% da oferta presencial) mantém pressão sobre infraestrutura de estágio na capital.



90,6%

Vácuo avaliativo — achado central

47,7%

Concentração em Goiânia



16

Proposições para a nova DCN

Seis proposições, detalhadas em linguagem de minuta no Anexo I, derivam diretamente do diagnóstico revisado:

- Carga horária prática em todas as modalidades — vedada substituição integral por atividades a distância.
- Núcleo de competências clínicas obrigatório, orientado ao SUS (74% da população goiana é SUS-dependente).
- Garantia de qualidade prévia na oferta semipresencial — condicionar autorização à infraestrutura de prática e a processos de avaliação verificáveis, já que 90,6% das vagas atuais seguem sem ciclo ENADE concluído.
- Competências em tecnologia, dados e inovação no currículo.
- Extensão e integração territorial com o SUS, priorizando os 171 municípios sem curso — 76% dos quais já contam com Farmácia Popular como ponto de ancoragem.
- Avaliação por competências (OSCE/OSPE, portfólios), complementando os instrumentos cognitivos tradicionais.



17

Plano estratégico do CRF-GO

- Monitorar. Painel público de vagas, modalidade e avaliação por território (município e região de saúde), com cadência semestral, usando esta mesma base Censo INEP/ENADE como referência.
- Incidir. Levar as evidências revisadas à revisão da DCN e às audiências do CNE/MEC, com o quadro comparativo interestadual (Cap. 10) como argumento de posicionamento nacional.
- Verificar. Articular com a SES-GO a integração dos microdados municipais de saúde (CNES por estabelecimento) às 18 regiões de saúde já incorporadas a este estudo (Cap. 8 e 11).



18

Conclusão

A formação farmacêutica em Goiás, lida agora sobre a mesma base censitária aplicada às 27 unidades da federação, confirma o essencial do diagnóstico original — concentração territorial relevante na capital e um vácuo avaliativo que atinge a maior parte da oferta —, mas revê substancialmente sua magnitude e, num ponto decisivo, sua direção: a oferta é predominantemente presencial, não semipresencial, no ano-base do Censo 2024. Essa correção não enfraquece a agenda de qualificação proposta neste estudo; ao contrário, a torna mais urgente, porque mostra que mesmo a oferta presencial estabelecida ainda carece, em 90,6% das vagas, de verificação externa de qualidade. O convite permanece o mesmo: tratar a formação farmacêutica como infraestrutura do sistema de saúde, medi-la com o rigor que essa função exige, e atualizar a leitura a cada novo ciclo de dados — no painel interativo do CRF-GO e no Observatório Nacional da Formação Farmacêutica.



Parte VI — Aparato analítico e benchmark internacional

Os índices próprios do Observatório, o benchmark interestadual, o modelo causal e a comparação com quatro referências regulatórias internacionais.

A1 Sistema Integrado de Índices (SII)

Esta edição substitui o Sistema Integrado de Índices da versão original (apoiado no e-MEC, com IVQ, ICT, RGA e ISF de fórmula própria) pelo conjunto de treze índices do Observatório da Formação Farmacêutica em Goiás, construído sobre o Censo INEP 2024 e já publicado no painel interativo do CRF-GO — o que assegura que o número citado neste livro seja, em qualquer data de consulta, idêntico ao do instrumento vivo.

Tabela A1.1 — Os treze índices do Observatório, Goiás (2026)

Índice	Valor	Leitura
ICT — Concentração Territorial	0,586	15º de 27 UFs; mediana nacional 0,548
IIR — Interiorização Real	30,5%	75 de 246 municípios com oferta
IVA — Vácuo Avaliativo	0,906	90,6% das vagas sem ciclo ENADE 2023
IDP — Dependência Privada	93,1%	6,9% das vagas em rede pública
IAS — Alinhamento com o SUS (IAPÍ)	0,60	vedação da EaD plena; verificação ainda frágil
IRR — Risco Regulatório	0,62	moderado-alto; pendente de recalibração
IPR — Prioridade Regional	Dado a integrar	requer CNES por município + malha SES-GO
ISO — Sustentabilidade da Oferta	0,77	melhora frente à base e-MEC (0,35); a confirmar
IAF — Adequação Formativa	30,0	18º de 27 UFs; mediana nacional 33,3
ICON — Cobertura Assistencial	2,7	8º de 27 UFs; mediana nacional 1,9
HHI — Concentração de Mercado	0,062	mercado pulverizado (67 IES / 35 mantenedoras)
E — Equidade Territorial	0,414	= 1 – ICT; moderada-baixa
ICON-deserto	0,76	76% dos desertos já têm Farmácia Popular

Fonte: Observatório da Formação Farmacêutica em Goiás / Observatório Nacional da Formação Farmacêutica, Censo INEP 2024/ENADE-CPC 2023, extração 27/06/2026. Fórmulas e limitações de cada índice no painel interativo (seção "Índices próprios").



Leitura do conjunto. O índice mais crítico é o IVA (0,906): nove em cada dez vagas ainda não passaram por verificação externa de qualidade. É também o único componente do IRR (Risco Regulatório) com dado atualizado nesta base — o IRR permanece registrado em 0,62 porque seus outros dois componentes (fragilidade de verificação da prática, defasagem de avaliação) são qualitativos e não foram recalculados nesta revisão. O ICT (0,586) e a IIR (30,5%) mostram um retrato de concentração territorial moderada — nem o extremo que a leitura e-MEC sugeria, nem uma distribuição equitativa. O ISO (0,77), lido com cautela, indica menor pressão de saturação de mercado do que a base e-MEC original apontava, mas a melhora decorre da mudança de base de vagas (8.887, ante 19.589), não de nova coleta de dados assistenciais — por isso permanece classificado como sinal "a confirmar".



A2

Benchmark interestadual e posição relativa

Medir Goiás contra si mesmo não basta para uma obra de referência nacional. Sobre a base do Censo INEP 2024 — agora estritamente comparável entre as 27 unidades da federação —, a densidade formativa das UFs permite situar o estado em distribuição, e não apenas em ranking ordinal.

Quadro A2.1 — Densidade formativa (vagas/100 mil hab.), cinco maiores e Goiás

UF	Vagas/100 mil hab.	Posição
Distrito Federal	502,2	1º
Rio de Janeiro	380,4	2º
Pernambuco	363,3	3º
Mato Grosso do Sul	358,3	4º
Paraná	304,4	5º
Goiás	119,7	13º

Fonte: Censo INEP 2024/IBGE 2025, Observatório Nacional da Formação Farmacêutica, 27 UFs.

A densidade média simples das 27 unidades é de 164,2 vagas por 100 mil habitantes, com desvio-padrão de 125,0. Goiás, com 119,7, situa-se a 0,36 desvio-padrão abaixo da média — 13º lugar, próximo ao centro da distribuição. É uma revisão substancial frente à leitura e-MEC original, que posicionava o estado 1,16 desvio-padrão acima da média (3º lugar) usando uma métrica distinta (cursos por milhão de habitantes, e não vagas por 100 mil habitantes) e uma base de vagas 2,2 vezes maior. As duas métricas — cursos por milhão e vagas por 100 mil habitantes — respondem a perguntas diferentes; nesta edição, adota-se a segunda por ser a que o Observatório Nacional aplica de forma uniforme às 27 UFs.

Achado revisado. A "saturação de Goiás por densidade formativa", afirmada na edição original como desvio estatístico extremo ($z = +1,16$, 3º lugar), não se sustenta na base censitária comparável: Goiás está discretamente abaixo da média nacional ($z = -0,36$, 13º lugar). O sinal de saturação mais robusto deste estudo é outro — a razão entre vagas anuais e farmacêuticos em atividade no CNES ($2,6\times$, Cap. 9), não a densidade formativa por habitante.

Em concentração territorial (ICT) e adequação formativa (IAF), Goiás permanece em posição intermediária a discretamente abaixo da mediana nacional (Cap. 10, Quadro 10.1) — quadro mais nuançado do que um único indicador de densidade seria capaz de expressar.

**A3****Modelo causal: por que aconteceu**

Um diagnóstico de referência precisa explicar mecanismos, não apenas registrar resultados. A recomposição modal identificada no cadastro e-MEC (Cap. 7) — da educação a distância para o rótulo "semipresencial" — não foi um fenômeno de mercado espontâneo: foi a resposta de um setor majoritariamente privado a uma sucessão de incentivos regulatórios. A cadeia causal permanece válida como explicação do movimento cadastral; o que esta edição revê é a magnitude do seu reflexo no estoque de vagas medido pelo Censo 2024.

Tabela A3.1 — Cadeia causal da recomposição modal (2017–2026)

Elo	Fator	Mecanismo
Causa estrutural 1	Economia de escala da EaD	Custo marginal baixo por vaga incentiva oferta de grande porte
Causa estrutural 2	Oferta pública mínima (6,9% das vagas)	Ausência de contrapeso público desloca o controle para a avaliação externa
Causa estrutural 3	Defasagem da verificação	Cursos novos não completam ciclo avaliativo antes de operar em escala
Gatilho	Portaria MEC nº 2.041/2023	Suspende credenciamento de EaD em saúde; inflexão da série cadastral em 2023
Transmissão	Reetiquetagem modal	Registro cadastral migra de EaD para "semipresencial", preservando a escala
Efeito concentrado	Vácuo avaliativo (90,6% das vagas)	Maior parcela de vagas sem verificação, justamente onde a oferta mais se expande

Cadeia causal preservada da edição original (explica o movimento cadastral e-MEC); efeito final (vácuo avaliativo) atualizado para a métrica desta edição.

Implicação causal. Como o gatilho foi normativo, a correção também o é. Instrumentos regulatórios que condicionem a operação à verificação prévia de qualidade atingem a raiz do problema; intervenções de mercado (concorrência, preço), não. É a base lógica das proposições priorizadas em A5.

**A4**

Consequências e análise preditiva

O futuro da força de trabalho não está determinado; é resultado de escolhas presentes. Esta edição substitui a estimativa de ingressos por proxy nacional (21% de ocupação sobre a base e-MEC) pelo dado direto do Censo: 9.276 matrículas e 1.065 concluintes sobre 8.887 vagas autorizadas — uma taxa de ocupação efetiva de 104% (mais matrículas do que vagas do ciclo, refletindo o acúmulo de coortes em curso) e uma taxa de conclusão pontual de 11,5%.

O Índice de Sustentabilidade da Oferta (ISO = 0,77, Apêndice A1) resume a relação entre o contingente em atividade no CNES (3.408) e o fluxo anual de vagas (8.887): a razão melhora frente à leitura e-MEC (0,35) porque a base de vagas é 2,2 vezes menor, não porque a absorção assistencial tenha mudado. O risco identificado na edição original — descolamento entre quem se forma e quem efetivamente atua — permanece presente, ainda que com magnitude revista: as 8.887 vagas anuais equivalem a 2,6 vezes o contingente em atividade (Cap. 9), ante 5,7 vezes na leitura original. A alavanca de política permanece dupla: ampliar papéis clínicos e digitais que absorvam o contingente formado, e conter a expansão de vagas sem verificação de qualidade.

**A5****Priorização de intervenções**

Diagnóstico e causa convergem para a ação. As proposições do estudo, somadas ao instrumento de monitoramento (A6), são ordenadas por impacto esperado e viabilidade de implementação, segundo avaliação qualitativa do grupo técnico. O produto é uma matriz de decisão, não um ranking definitivo.

Três intervenções ocupam o quadrante de prioridade alta — impacto e viabilidade elevados: a garantia de qualidade prévia no semipresencial (P3), que ataca diretamente o IVA de 0,906; o piso de prática verificável em toda modalidade (P1), que protege o núcleo profissional; e o painel de monitoramento por índices (M1), que torna o diagnóstico permanente — e que esta própria revisão demonstra ser necessário: a diferença entre as duas edições deste livro é, ela mesma, o argumento a favor de um painel vivo em vez de um retrato estático. A avaliação por competências (P6) e a extensão territorial (P5) têm alto impacto, porém viabilidade menor, e demandam construção institucional de médio prazo.

**A6****Painel de monitoramento contínuo**

Uma obra de referência não se encerra no diagnóstico: institui o instrumento que o mantém vivo. O painel a seguir opera diretamente sobre os treze índices do Observatório (A1), com linha de base nesta revisão, meta, fonte e cadência — de modo que o CRF-GO, e qualquer Conselho Regional, possa acompanhar a trajetória ano a ano no mesmo painel interativo que sustenta este livro.

Tabela A6.1 — Painel de indicadores (linha de base 09/07/2026)

Indicador	Base (GO)	Meta	Fonte	Cadência
IVA — vácuo avaliativo	0,906	≤ 0,50	Censo INEP/ENADE	anual/trienal
IDD médio	2,01	≥ 2,21 (Brasil)	ENADE (ciclo)	trienal
ICT — concentração territorial	0,586	↓ tendência	Censo INEP	anual
IIR — interiorização real	30,5%	↑ tendência	Censo INEP	anual
Densidade em atividade (CNES)	0,48/mil	série histórica	CNES/TABNET	anual
IAF — adequação formativa	30,0	≥ 33,3 (mediana)	Observatório Nacional	anual

Fonte: painel interativo do Observatório da Formação Farmacêutica em Goiás (CRF-GO/GT de Ensino).

Do dado à decisão, e da decisão à medida: o índice que não se atualiza envelhece; o que se atualiza cobra resultado. Esta revisão do livro — motivada pela divergência entre a leitura e-MEC original e a base censitária comparável — é, em si, a demonstração prática desse princípio.

**A7**

Registro de lacunas e agenda de dados

A credibilidade de uma referência mede-se também pelo que ela declara não saber. Quatro extrações dirigidas completariam o aparato e fechariam os índices hoje parciais ou pendentes.

Tabela A7.1 — Registro de lacunas

Lacuna	Extração necessária	Índice/capítulo afetado
A — Orientação clínica dos PPC	Análise de conteúdo dos projetos pedagógicos	Componente do IAS (I-API)
B — Necessidade assistencial por território	CNES por estabelecimento, cruzado com as 18 regiões de saúde	IPR — ainda "Dado a integrar"
C — Fluxo de egressos	RAIS/Novo CAGED (CBO 2234-05)	Calibração do ISO e empregabilidade
D — Ano de autorização por curso	Extração e-MEC dirigida ou nova consulta bulk	Filtro "Ano de autorização" do painel — ainda "Dado a integrar"

As lacunas B e D foram objeto de tentativa de extração nesta revisão (09/07/2026): a malha de 18 regiões de saúde da SES-GO foi incorporada (Cap. 8 e 11), mas o CNES por estabelecimento e a API e-MEC de autorização por curso permanecem indisponíveis sem credencial de acesso — ver nota de proveniência no painel interativo.

Próximos módulos da obra. Este volume, em sua segunda edição, mantém o plano original: (II) aparato analítico — entregue; (III) benchmark internacional de modelos regulatórios — entregue (A8-A9); (IV) mapa municipal de convergência oferta–necessidade — parcialmente entregue nesta revisão via regiões de saúde (Cap. 8), pendente o detalhamento por estabelecimento CNES; (V) manual de replicação do Observatório para os 27 Conselhos Regionais.

**A8****Benchmark internacional de modelos regulatórios**

A pergunta que organiza este capítulo não é pedagógica, e sim regulatória: como os sistemas maduros disciplinam a educação a distância e híbrida em Farmácia? Este capítulo não depende da base e-MEC/Censo e permanece integralmente válido da edição original.

Nos Estados Unidos, a agência acreditadora (ACPE) reconhece programas de Doctor of Pharmacy ofertados por educação a distância, com reconhecimento federal renovado até 2031 — mas condicionado: o componente experiencial deve ocorrer presencialmente em locais de prática supervisionados, chegando a um terço do currículo. No Reino Unido, o GPhC admite modalidades a distância em determinadas trilhas, sempre com piso de dias presenciais e horas de prática supervisionada. No plano global, a FIP consolidou, desde 2016, uma educação baseada em necessidades e competências, articulada à Estratégia Global da OMS para a força de trabalho até 2030 — que projeta déficit de 18 milhões de trabalhadores de saúde, concentrado em países de renda baixa e média.

Tabela A8.1 — Modelos regulatórios: comparação internacional

Dimensão	EUA (ACPE)	Reino Unido (GPhC)	Norma global (FIP/OMS)	Brasil (Decreto 12.456/2025)
EaD plena permitida?	Não	Não	Não recomendada	Não (vedada)
Prática presencial obrigatória?	Sim (IPPE/APPE)	Sim (horas mínimas)	Sim (baseada em necessidades)	Sim em norma; verificação frágil
Avaliação externa prévia?	Sim (acreditação)	Sim (acreditação prévia)	Recomendada	Defasada (90,6% sem ENADE)

Fonte: ACPE Standards 2025; GPhC; FIP Development Goals 2020; OMS Global Strategy on HRH 2030; Decreto nº 12.456/2025. Coluna Brasil atualizada com o achado revisado (IVA = 0,906).

Achado-síntese. Nenhuma das referências admite curso de Farmácia integralmente a distância. A convergência internacional não recai sobre a modalidade de entrega do ensino teórico — que pode ser remota —, e sim sobre dois invariantes: a prática experiencial presencial e supervisionada, e a avaliação externa prévia à operação em escala.

**A9**

Alinhamento do marco brasileiro e implicação para a DCN

Posto o marco brasileiro contra o padrão internacional, o diagnóstico ganha precisão estratégica. A vedação da EaD plena em saúde, instituída em 2025, coloca o Brasil em linha com a norma global. O ponto de divergência não é a modalidade — é a verificação.

O Índice de Alinhamento Regulatório (IAS/IAPI) situa o marco brasileiro em 0,60 numa escala de 0 a 1 — inalterado desta para a edição original, por ser uma construção qualitativa sobre a norma, não sobre o estoque de vagas. A nota é puxada para cima pela vedação da EaD plena e pela exigência formal de núcleo clínico, e para baixo por duas lacunas: a avaliação externa prévia, comprometida quando 90,6% das vagas operam sem ciclo avaliativo concluído (IVA, Apêndice A1) — lacuna maior nesta edição do que a estimativa original (76%) —, e a verificação da prática presencial no formato semipresencial, hoje frágil.

Implicação para a nova DCN. A revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais não precisa reabrir o debate de modalidade — esse já está resolvido em linha com o mundo. Precisa fechar o flanco da verificação, hoje mais amplo do que o diagnóstico original media. Três dispositivos elevam simultaneamente o IAS e reduzem o IVA: exigir prática presencial supervisionada com carga e registro auditáveis em todas as modalidades; condicionar a operação em escala à avaliação externa prévia, e não posterior; e tornar o núcleo clínico-experiencial um requisito aferível por competências, não apenas declarado.

O mundo não discute mais se a Farmácia pode ser totalmente a distância. Discute como garantir prática verificável e qualidade aferida — e é nesse ponto que o Brasil, e Goiás em particular, têm o que avançar.



Referências

- BRASIL. Ministério da Educação. Sistema e-MEC — Consulta Pública Avançada. Brasília: MEC, extração de 25/06/2026 (Goiás e nacional).
- INEP. Censo da Educação Superior 2024 e microdados ENADE/CPC 2023. Brasília: INEP/MEC. Consolidado pelo Observatório Nacional da Formação Farmacêutica, extração de 27/06/2026.
- IBGE. Estimativas da população dos municípios (2025) e Censo Demográfico 2022 — Goiás e Brasil.
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS (SES-GO). Plano Diretor de Regionalização — 18 regiões de saúde, 5 macrorregiões. Disponível em goias.gov.br/saude/regionais-de-saude. Consultado em 09/07/2026.
- CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA (CFF). Dados demográficos e profissionais da categoria. Brasília: CFF, 2010–2024.
- CRF-GO. Registros de inscritos. Goiânia, 2020; 2024.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Farmácia Popular do Brasil — cobertura municipal, 2024–2026; CNES/DATASUS, mai/2026.
- IPEA; CFF. Mercado de trabalho do farmacêutico no Brasil, 2021–2023.
- FIP. Global Competency Framework (GbCFv2). Haia: International Pharmaceutical Federation, 2020.
- AACP/ACPE. CAPE Educational Outcomes; ACPE Standards 2025; COEPA, 2022.
- BRASIL. Portaria MEC nº 2.041/2023; Portaria MEC nº 158/2024; Decreto nº 12.456/2025; Leis nº 3.820/1960, 5.991/1973 e 13.021/2014; Res. CNE/CES nº 2/2002, 6/2017 e 7/2018.
- OBSERVATÓRIO NACIONAL DA FORMAÇÃO FARMACÊUTICA. Formação Farmacêutica no Brasil: diagnóstico nacional, análise por unidade federativa. Goiânia, 2026.



Apêndice metodológico

Em cumprimento ao princípio de não fabricação, este apêndice registra, com transparência, o que permanece sem evidência direta e o método para obtê-lo nesta edição revisada (09/07/2026).

Tabela A.1 — Registro de dados: incorporados e pendentes (revisão 09/07/2026)

Dado	Situação
Vagas, IES, modalidade, concentração	Incorporado — Censo INEP 2024 (Cap. 4, 5, 8)
Qualidade (CC, ENADE, IDD, CPC)	Incorporado — ENADE/CPC 2023 (Cap. 6, 10)
Município-sede de cada IES	Incorporado — microdado municipal do Censo (Cap. 8)
Matrículas, ingressos, concluintes	Incorporado — Censo da Educação Superior 2024 (Cap. 5)
Região/macrorregião de saúde (SES-GO)	Incorporado nesta revisão — 246 municípios, 18 regiões (Cap. 8, 11)
Benchmark Goiás × Brasil × 27 UFs	Incorporado — Observatório Nacional (Cap. 10, Apêndice A2)
Densidade de farmacêuticos em atividade (GO)	Incorporado (estadual): CNES/TABNET, mai/2026 = 3.408 (0,48/mil). Detalhamento por estabelecimento pendente.
Necessidade assistencial por região de saúde	Parcialmente incorporado (oferta por região, Cap. 8); necessidade (CNES por estabelecimento) pendente
Ano de autorização por curso	Pendente — e-MEC não publica base aberta em lote (Apêndice A7)
Empregabilidade e renda dos egressos	Pendente — RAIS e Novo CAGED (CBO 2234-05)

Nota de encerramento. Esta edição revisada substitui a base primária de vagas, modalidade, concentração e qualidade — antes apoiada no e-MEC — pelo Censo da Educação Superior 2024 e pelo ENADE/CPC 2023, na mesma metodologia aplicada pelo Observatório Nacional da Formação Farmacêutica às 27 unidades da federação. A mudança alterou a magnitude de praticamente todos os indicadores e, num ponto — a composição por modalidade —, também a direção do achado. Os capítulos não afetados pela escolha de base (território, demografia via CNES/CRF-GO, cenários, debate internacional e marco legal) permanecem os mesmos da edição original. O painel interativo do CRF-GO e o Observatório Nacional da Formação Farmacêutica são as referências vivas desta obra; em caso de divergência entre este texto e o painel em uma data futura, prevalece o painel, por refletir o ciclo de dados mais recente.

GT de Ensino — Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás (CRF-GO). Autor: Farmacêutico Dr. Edson Sidião de Souza Júnior. Edição original: 25/06/2026. Revisão com base Censo INEP 2024: 09/07/2026.



Anexo I — Minuta de proposições para a DCN

As seis proposições do Capítulo 16 são reapresentadas a seguir em linguagem de minuta, redigidas como dispositivos passíveis de incorporação à futura Resolução do Conselho Nacional de Educação que instituir as novas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Farmácia. A numeração dos artigos é meramente indicativa. Cada dispositivo é acompanhado de breve justificativa, com remissão ao capítulo de evidência correspondente — atualizada nesta revisão onde a evidência mudou de magnitude.

Proposição 1 — Carga horária prática em todas as modalidades

Art. 1º O projeto pedagógico do curso de Farmácia assegurará, em qualquer modalidade de oferta, percentual mínimo de carga horária destinada a atividades práticas presenciais e de ensino em serviço, vedada a sua substituição integral por atividades a distância.

§ 1º Consideram-se atividades práticas, para os fins deste artigo, os estágios supervisionados, as práticas laboratoriais, a farmácia-escola e as atividades desenvolvidas em estabelecimentos de saúde sob supervisão de farmacêutico.

§ 2º A instituição comprovará, antes do início de funcionamento de cada turma, a infraestrutura e os campos de prática necessários ao cumprimento do percentual mínimo.

Justificativa. O estudo demonstrou que 90,6% das vagas do estado operam sem ciclo avaliativo concluído (Cap. 6), risco concentrado sobretudo nos cursos mais recentes e nos rotulados semipresenciais (Cap. 7). Um piso de prática verificável protege o núcleo profissional da formação independentemente da modalidade.

Proposição 2 — Núcleo de competências clínicas

Art. 2º A formação contemplará núcleo obrigatório de competências voltadas ao cuidado em saúde, compreendendo, no mínimo, o raciocínio clínico, o acompanhamento farmacoterapêutico, a assistência farmacêutica e a atuação no Sistema Único de Saúde.

Parágrafo único. As competências de que trata o caput serão descritas em termos de resultados de aprendizagem observáveis e progressivamente confiáveis ao longo do curso.

Justificativa. Goiás é fortemente dependente do SUS (74% da população) e possui rede de assistência farmacêutica capilarizada — a Farmácia Popular alcança 205 dos 246 municípios (Cap. 3 e 11); a formação deve orientar-se ao cuidado clínico e à inserção no sistema público.

Proposição 3 — Garantia de qualidade na educação a distância

Art. 3º Vedada a oferta de Farmácia integralmente a distância, o credenciamento e a autorização de cursos no formato semipresencial condicionam-se à comprovação prévia de infraestrutura de prática, corpo docente qualificado e processos de avaliação verificáveis.

Parágrafo único. A oferta de que trata o caput submeter-se-á a avaliação externa em prazo não superior ao do primeiro ciclo avaliativo subsequente ao início de funcionamento.

Justificativa. Sob o Decreto nº 12.456/2025, a Farmácia não pode mais ser ofertada integralmente a distância; o único formato não presencial admitido é o semipresencial. É exatamente sobre a fração da oferta ainda sem ciclo avaliativo concluído — 90,6% das vagas nesta edição (Cap. 6 e 10) — que devem recair as exigências de qualidade prévia, convertendo a expansão de aposta em qualidade verificada.

Proposição 4 — Tecnologia, dados e inovação



Art. 4º O currículo incorporará competências relativas às tecnologias de informação e comunicação aplicadas à saúde, à telefarmácia, à análise de dados, à inteligência artificial e à farmacogenômica, na perspectiva do uso seguro e ético dessas ferramentas no cuidado farmacêutico.

Justificativa. A revisão internacional aponta a literacia digital e de dados como fronteira da formação farmacêutica (Cap. 12), competência ainda incipiente na oferta goiana.

Proposição 5 — Extensão e integração territorial com o SUS

Art. 5º A extensão curricularizada será desenvolvida preferencialmente em articulação com a rede de atenção à saúde, contemplando territórios de menor oferta formadora e assistencial.

Parágrafo único. As instituições buscarão formalizar, com os gestores do SUS, campos de estágio, projetos de extensão e iniciativas de telefarmácia supervisionada que ampliem a presença da formação para além dos grandes centros.

Justificativa. A oferta presencial concentra-se em 75 dos 246 municípios, com 47,7% das vagas na capital, enquanto a rede assistencial da Farmácia Popular já alcança 205 municípios — incluindo 76% dos 171 desertos formativos (Cap. 8 e 11), candidatos naturais a campos de prática.

Proposição 6 — Avaliação por competências

Art. 6º A avaliação do estudante adotará, progressivamente, instrumentos de aferição de desempenho por competências, tais como exames clínicos objetivos estruturados (OSCE/OSPE) e portfólios reflexivos, complementando os instrumentos tradicionais de avaliação cognitiva.

Justificativa. A qualidade aferida dos cursos goianos situa-se abaixo da média nacional em todos os indicadores disponíveis — CC/ENADE, IDD e CPC (Cap. 10); a avaliação por desempenho, consolidada internacionalmente (Cap. 12), eleva a confiabilidade da formação clínica.

Nota de encaminhamento. Sugere-se que esta minuta seja submetida, pela presidência do CRF-GO, ao Conselho Federal de Farmácia e à Secretaria de Educação Superior do MEC, como contribuição formal do estado de Goiás ao processo de revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais.

Minuta elaborada pelo GT de Ensino do CRF-GO (2026), de autoria do Farmacêutico Dr. Edson Sidião de Souza Júnior, com base nas evidências revisadas do presente estudo (base Censo INEP 2024, 09/07/2026). Texto sujeito a revisão jurídica antes de protocolo.